悬钟穴临床运用举隅

葛宙挺
(张家港市第二人民医院,江苏 张家港 215633)

关键词:眩晕;落枕;胁痛;穴,悬钟
中图分类号:R245.9 文献标识码:B 文章编号:1004-6852(2003)05-0052-01

悬钟穴,又名绝骨穴,是足少阳胆经腧穴,又是八会穴中的髓会穴。笔者临床运用此穴治疗多种疾病,常取得显著疗效,现报道如下。

1 眩晕(美尼尔氏病)

徐某,女,70岁。有眩晕病史40年,间断发作,一般经数小时能自行缓解。本次于3天前因劳累眩晕又起,头昏眼花,视物旋转,耳鸣,听力减退,恶心呕吐,平卧时诸症减轻,起身或活动时加重,3天未能缓解。查:血压135/80 mmHg,眼球呈水平震颤。脑电图、脑CT检查均无异常。诊断为美尼尔氏病。收住入院,入院后经用654-2、晕海宁等对症治疗,5天后,症状无明显好转。邀余诊,取双侧悬钟穴为主,配以足三里、肾俞、三阴交等穴,主穴每次必取,配穴随症加减,均用补法,得气后,留针20分钟,中间行针1次,每日1次。3天后,视物旋转消失,耳鸣减轻。再治疗5天,诸症消失,唯听力不如以前,再经7天治疗,痊愈出院。

按 本病患者年老体衰,肝肾不足,加之久病不愈耗伤肾气,而致肾精空虚,不能生髓,髓海不足,则发为眩晕。头为诸阳之首,髓海之所在,髓海不足,则脑转耳鸣,目无所见,懈怠安卧。《灵枢·口问》云:"上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。"悬钟穴是八会穴中的髓会,历代医家均用之治疗"髓所生病"。故取悬钟穴为主,配以肾俞、足三里等,补肾益精增髓之效。

2 落枕(颈部伤筋)

李某,男,32岁,患者因昨晚看电视时,头枕床头,姿势不正,今晨起后觉颈部疼痛,不能向左歪头和转动。检查:颈后右侧肌肉痉挛强直,压痛明显,无红肿,颈部活动受限。诊断为落枕性颈痛。取用右侧悬钟穴治疗,进针后针尖略向上斜刺,得气后保持轻轻捻转,针感向膝股方向传导,同时嘱患者摇动颈项。如此持续5分钟后,疼痛大减,活动好转,留针15分钟后,如上法再操作5分钟出针,患者疼痛尽除,活动如常。第2天复诊:颈部运动良好,已无疼痛,仅感右颈肌肉略紧,再予以悬钟穴针刺得气后留针20分钟,痊愈而归。

按 本病例因姿势不当,使颈部骨节筋肉遭受长时间的过度牵拉,致经络受损,气血运行受阻,气机阻滞,血运不畅,而发生颈项强痛。颈项系足少阳胆经循行部位。在十四经腧穴中,尤其是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的腧穴,不仅能治局部病症,而且能治本经循行所涉及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病症。诚如窦汉卿所说:"泻络远针,头有病而脚上针。"悬钟穴善治本经经脉通路上的病症,以起到疏通经络,行气活血的作用,使气血正常运行,经络通畅,以达到通则不痛的目的。

3 胁痛(胆绞痛)

杨某,男,38岁,患者因食油腻后,上腹疼痛,阵发性加重,进而伴恶心呕吐半小时,来诊。经外科检查:体温正常,神志清,痛苦状,角膜及皮肤无黄染,莫菲氏征(+),肌紧张。B超检查示:胆囊炎,胆结石。诊断为:胆囊炎,胆结石。予以静滴青霉素、丁胺卡那,肌注654-2、杜冷丁。1小时后,疼痛仍未缓解,邀余会诊,取双侧悬钟穴,配双侧侠溪穴,均用泻法,强刺激,不断交替捻针。20分钟后,疼痛减轻,恶心呕吐消失,至第2天复诊时,未再绞痛,予上法巩固治疗,疼痛消失,活动如常。

按 凡情志不畅,饮食不节,过食油腻,寒温不适或虫积内滞,均可导致肝胆之气郁滞,湿热蕴结,影响肝胆功能,不通则痛。《灵枢·经脉》论述胆经病候时说:"是动则病口苦,善太息,心胁痛,不能转侧。"根据经络学说"内属于府藏,外络于肢节",肢节之穴,能治内腑之疾,故取悬钟,以疏通肝胆之气,侠溪为胆经荥穴,善解少阳之郁火,二穴配用能止胸胁疼痛。(收稿日期 2002-06-18)

中国知网 https://www.cnki.net